

Strategii contemporane în tratamentul alergiei alimentare la proteinele laptelui de vacă

Contemporary strategies in the management of cow's milk protein allergy

Elena-Camelia Berghea

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România; Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M. S. Curie”, București, România

Autor corespondent: Elena-Camelia Berghea, e-mail: bcamelia@gmail.com

ABSTRACT

Cow's milk protein allergy (CMPA) is the most common food allergy in infants and young children, with a prevalence estimated between 2% and 4.9%. This paper reviews the latest data on the diagnosis and management of CMPA, covering both IgE-mediated and non-IgE-mediated forms. The diagnosis of IgE-mediated CMPA involves skin prick testing, measurement of specific IgE levels, and, if necessary, basophil activation tests, confirmed by oral food challenge. For non-IgE-mediated CMPA, diagnosis is based on clinical response to elimination and reintroduction diets. Management of IgE-mediated forms includes avoidance of the implicated food, individualized dietary counseling, education regarding the use of adrenaline autoinjectors, and the potential use of oral immunotherapy. In non-IgE-mediated forms, the main treatment consists of dietary exclusion, continued breastfeeding where possible, and the use of extensively hydrolyzed or amino acid-based formulas when necessary. Oral immunotherapy and biological therapies offer new perspectives, but their application is currently limited to specialized centers and carefully selected patients.

Keywords: cow's milk protein allergy (CMPA), IgE-mediated allergy, non-IgE-mediated allergy, oral immunotherapy

REZUMAT

Alergia la proteinele laptelui de vacă (APLV) reprezintă cea mai frecventă alergie alimentară la sugari și copii mici, cu o prevalență estimată între 2% și 4,9%. Lucrarea revizuieste ultimele date despre diagnosticul și managementul APLV, incluzând formele IgE-mediate și non-IgE-mediate. Diagnosticul APLV IgE-mediată implică teste cutanate prick, dozări de IgE specifice și eventual testul de activare a bazofililor, fiind confirmat prin test de provocare orală. Pentru APLV non-IgE-mediată, diagnosticul se bazează pe răspunsul clinic la dieta de eliminare și reintroducere alimentară. Managementul formelor IgE-mediate include evitarea alimentului implicat, consiliere dietetică individualizată, educație privind utilizarea adrenalinei autoinjectabile și posibil imunoterapie orală. În formele non-IgE-mediate, tratamentul principal este dieta de excludere, menținerea alăptării și utilizarea de formule hidrolizate sau pe bază de aminoacizi, când este necesar. Imunoterapia orală și terapiile biologice aduc noi perspective, dar aplicarea lor este limitată la centre specializate și la pacienți atent selectați.

Cuvinte-cheie: alergie la proteinele laptelui de vacă (APLV), alergie IgE-mediată, alergie non-IgE-mediată, imunoterapie orală

Introducere

Alergia la proteinele laptelui de vacă (APLV) reprezintă cea mai frecventă alergie alimentară întâlnită la sugari și copii mici, cu o prevalență estimată între 2–3% și până la 4,9% în anumite populații^(1,2).

Diagnosticarea corectă a APLV este esențială, deoarece atât supradiagnosticarea, cât și subdiagnosticarea pot avea consecințe negative asupra sănătății pe termen lung⁽²⁾. Pe de o parte, evitarea inutilă a laptelui de vacă poate duce la carențe nutriționale semnificative, iar, pe de altă parte, lipsa diagnosticării corecte poate expune copilul la reacții alergice severe. Cele mai mari dificultăți în stabilirea diagnosticului sunt generate de suprapunerea simptomatologiei APLV cu alte patologii pediatrice comune sau cu manifestările normale ale sugarului sănătos^(2,3).

În ultimii ani au fost propuse noi abordări diagnostice și terapeutice, inclusiv diagnosticul molecular și imunoterapia orală, care ar putea schimba paradigmele clasice bazate exclusiv pe evitarea alimentului alergen^(4,5).

Această lucrare își propune să sintetizeze cele mai recente date privind diagnosticul, manifestările clinice și managementul APLV, cu accent atât pe formele IgE-mediate, cât și pe cele non-IgE-mediate.

Definiții și clasificare

Conform definiției propuse de World Allergy Organization, alergia la proteinele laptelui de vacă (APLV) reprezintă o reacție de hipersensibilitate inițiată de mecanisme imunologice specifice, care apare după expunerea la proteinele din laptele de vacă⁽¹⁾. Din punctul de vedere al mecanismelor, APLV se clasifică în două categorii majore:

APLV IgE-mediată

Această formă de alergie implică producerea de imunoglobuline de tip E (IgE) specifice împotriva proteinelor din laptele de vacă. Simptomele apar rapid, în general în decurs de câteva minute până la 1–2 ore de la ingestia alimentului. Diagnosticul este susținut de teste cutanate prick pozitive sau de detectarea unor niveluri crescute de IgE specifice pentru proteinele lactate^(1,2).

APLV non-IgE-mediată

Această formă implică mecanisme imune predominant celulare, fără implicarea anticorpilor IgE. Simptomele sunt în general întârziate, apărând la câteva ore până la câteva zile de la ingestie, și pot imita tulburările funcționale gastrointestinale pediatrice^(2,3). Diagnosticul este în principal

Tabelul 1 Clasificarea reacțiilor alergice induse de alimente (adaptat după Jensen et al.)⁽¹⁾

Mediate IgE	Mediate mixt IgE și non-IgE	Mediate non-IgE
Cutanat		
Urticarie și urticarie de contact	Dermatită atopică	
Angioedem		Dermatită de contact
Erupție eritematoasă morbiliformă		
Înroșire facială (flushing)		
Respirator		
Rinoconjunctivită alergică	Astm	Hemosideroză pulmonară indusă de alimente (Sindromul Heiner)
Bronhospasm acut		
Gastrointestinal		
Sindromul alergiei orale	Esofagită eozinofilică (EoE)	Sindrom de enterocolită indusă de proteine alimentare (FPIES)
Spasm gastrointestinal acut	Gastrită eozinofilică	Proctocolită indusă de proteine alimentare (FPIES)
	Gastroenterită eozinofilică	
Cardiovascular		
Amețeli, lipotimie		
Anafilaxie		
Anafilaxie asociată alimentelor, indusă de exercițiu fizic		
Diverse		
Crampe și contracții uterine		
Senzație de pericol iminent		

clinic și se bazează pe răspunsul la dieta de excludere și testul de provocare orală.

Forme mixte, în care sunt implicate atât mecanisme IgE-mediate, cât și non-IgE-mediate, ceea ce poate complica și mai mult tabloul clinic și abordarea terapeutică⁽²⁾.

Diagnosticul APLV

Diagnosticarea alergiei la proteinele laptelui de vacă (APLV) rămâne o provocare majoră, datorită variabilității manifestărilor clinice și a suprapunerii simptomelor cu alte patologii pediatrice comune^(1,2). Abordarea diagnosticului diferă în funcție de mecanismul imunologic implicat:

1. Diagnostic în APLV IgE-mediată

Algoritmul de diagnostic în alergია alimentară IgE-mediată

Diagnosticul alergiei alimentare IgE-mediate începe întotdeauna de la istoricul clinic detaliat. Suspiciunea de alergie se bazează pe existența unei reacții caracteristice după consumul unui aliment specific.

În funcție de informațiile obținute din anamneză, algoritmul recomandat de ghidul EAACI pentru diagnosticul alergiilor alimentare IgE-mediate se regăsește în tabelul 2⁽⁴⁾.

La copiii diagnosticați cu alergie alimentară IgE-mediată se recomandă reevaluări periodice, pentru a detecta eventuala rezoluție spontană a alergiei, un fenomen frecvent întâlnit în copilărie⁽⁴⁾. În cazurile unde diagnosticul rămâne incert, testul de provocare orală controlat (TPO) reprezintă standardul de aur pentru confirmarea diagnosticului. TPO se efectuează în condiții controlate, cu supraveghere medicală atentă⁽⁴⁾.

2. Diagnostic în APLV non-IgE-mediată

Reacțiile alergice non-IgE-mediate reprezintă un grup eterogen de afecțiuni imunologice caracterizate printr-un debut întârziat al simptomelor, apărute la câteva ore sau chiar zile după expunerea la alergenul alimentar. Diagnosticul acestor condiții rămâne o provocare majoră în practica pediatrică, întrucât lipsesc în prezent teste de laborator standardizate care să permită confirmarea lor directă⁽⁵⁾. În absența unor biomarkeri specifici, diagnosticul reacțiilor non-IgE-mediate se bazează în principal pe o evaluare clinică detaliată. Istoricul pacientului are un rol central, urmărindu-se apariția simptomelor digestive recurente precum diareea cronică, vărsăturile persistente, constipația severă, colicile abdominale sau prezența de sânge vizibil în scaun. Relația temporală dintre ingestia alimentului suspect și debutul simptomelor, deși adesea mai puțin evidentă decât în alergiile IgE-mediate, constituie un indiciu important^(5,6).

Confirmarea diagnosticului presupune inițierea unei diete de eliminare, prin care alimentul suspectat este exclus complet din alimentație pentru o perioadă de două până la patru săptămâni. Remisia simptomelor în această perioadă susține suspiciunea clinică. Pentru validarea definitivă a diagnosticului, se recomandă reintroducerea atent monitorizată a alimentului eliminat. Reapariția simptomelor după reexpunere confirmă caracterul alimentar al reacțiilor observate⁽⁵⁾.

În formele ușoare și moderate, această procedură de eliminare și reintroducere se poate efectua în condiții de ambulatoriu, cu monitorizare parentală atentă. În schimb, la copiii cu reacții severe, precum cei cu sindrom de enterocolită indusă de proteine alimentare (FPIES), testele de provocare trebuie efectuate în spital, sub supraveghere medicală strictă. Evaluările paraclinice adjuvante sunt rezervate cazurilor ati-

Tabelul 2

Algoritm pentru secvențele de testare recomandate pentru susținerea diagnosticului de alergii alimentare IgE-mediate (adaptat după Santos AF et al.)⁽⁴⁾

Etapă	Situație clinică / Rezultat testare	A acțiune recomandată	Următorul pas
1. Suspiciune inițială	Suspiciune de alergie IgE-mediată, bazată pe istoricul clinic	Realizare SPT la extracte/aliment proaspăt și/sau IgE specifice pentru alimente suspionate	Interpretare rezultate
2. Interpretare SPT/IgE	Istoric clar de reacție + sensibilizare IgE/SPT	Confirmare posibilă	Se poate continua spre test de provocare orală (TPO) sau tratament
	Istoric echivoc sau rezultate contradictorii SPT/IgE	Testare suplimentară	IgE specifice componente alergice și/sau test de activare a bazofilelor (BAT)
	Fără istoric de reacție + teste negative	Excluderea diagnosticului	Alimentul poate fi consumat
3. Testare suplimentară	IgE detectabil la componente relevante	Continuare investigații	BAT
	IgE nedetectabil / BAT negativ	Reevaluare clinică sau provocare orală	TPO
4. Test de activare bazofilică (BAT)	BAT pozitiv	Susține diagnosticul de alergie	Se poate confirma alergია sau se efectuează TPO
	BAT negativ	Reevaluare clinică	TPO recomandat
5. Test de provocare orală (OFC)	TPO pozitiv	Confirmarea diagnosticului de alergie IgE-mediată	Diagnosticul final
	TPO indeterminat	Reevaluare ulterioară	Decizie clinică individualizată
	TPO negativ	Excluderea alergiei IgE-mediate	Alimentul poate fi reintrodus

Tabelul 3

Performanțe diagnostice ale diferitelor teste pentru alergia la lapte bazate pe rezultate ale unor metaanalize recente (adaptat după Santos AF et al.)⁽⁴⁾

Test de diagnostic	Prag de pozitivitate (cut-off)	Sensibilitate	Specificitate
Test cutanat prick (Skin Prick Test)	4 mm (interval: 3–8 mm)	0,52 (interval: 0,24–0,79)	0,80 (interval: 0,65–0,90)
IgE specifică față de extracte alergice	3,5 kU/L (interval: 0,9–10,5 kU/L)	0,82 (interval: 0,59–0,94)	0,92 (interval: 0,80–0,97)
IgE specifică față de componente alergice (ex.: cazeină)	2,6 kU/L (interval: 1,0–5,3 kU/L)	0,67 (interval: 0,53–0,78)	0,93 (interval: 0,85–0,97)
Test de activare a bazofilelor (BAT)	Prag exprimat ca procent CD63+ bazofile activate	Sensibilitate înaltă (valoare exactă neraportată aici)	Specificitate înaltă (valoare exactă neraportată aici)

pice sau severe. Investigații precum măsurarea nivelurilor serice de albumină, dozarea fierului sau determinarea alfa-antitripsinei fecale pot sprijini evaluarea complicațiilor nutriționale sau a pierderilor proteice gastrointestinale. Biopsia endoscopică este indicată doar când există suspiciuni privind alte patologii concomitente, cum ar fi boala inflamatorie intestinală sau eozinofilia gastrointestinală⁽⁶⁾.

Testele cutanate prick, determinarea IgE serică specifică sau testele patch nu sunt utile în diagnosticul reacțiilor non-IgE-mediate și nu sunt recomandate în protocolul standard de evaluare, însă evaluarea capătă semnificație în cazul formelor atipice de alergii non-IgE-mediate care asociază teste prick sau IgE specifice pozitive, aspect important în cazul deciziei tipului de test de provocare pentru reintroducerea alimentelor în dietă.

De asemenea, este importantă diferențierea între diversele entități clinice care intră în spectrul reacțiilor non-IgE-mediate. Proctocolita alergică indusă de proteine alimentare (FPIAP) se manifestă prin prezența striurilor de sânge în scaunul sugarilor sănătoși și răspunde prompt la eliminarea proteinelor din laptele de vacă din dieta mamei și/sau din alimentația copilului. Enteropatia indusă de proteine alimentare (FPE) îmbracă tabloul clinic de diaree cronică și stagnare în creștere, necesitând uneori evaluare endoscopică pentru confirmare. Sindromul FPIES se carac-

terizează prin reacții acute severe, cu vărsături profunde și letargie, debutând la una până la patru ore după ingerarea alimentului declanșator⁽⁵⁾.

În cazul esofagitei eozinofilice (EoE), care poate avea o componentă imunologică non-IgE-mediată, diagnosticul se bazează pe documentarea histologică a infiltratului eozinofilic prin biopsii esofagiene, cu identificarea a peste 15 eozinofile per câmp microscopic.

În concluzie, diagnosticul reacțiilor alimentare non-IgE-mediate la copii necesită o abordare clinică sistematică, cu o atenție sporită acordată istoricului detaliat, răspunsului la dieta de eliminare și testului de reprovocare alimentară. Această strategie rămâne esențială în lipsa unor teste paraclinice specifice și este indispensabilă pentru evitarea diagnosticelor greșite și a restricțiilor alimentare nejustificate. La sugarii la care se suspectează o alergie ușoară până la moderată la proteinele laptelui de vacă (APLV), managementul recomandat constă într-o abordare etapizată, în trei pași principali, având ca scop confirmarea sau excluderea diagnosticului și optimizarea terapiei.

Conform recomandărilor recente publicate de Meyer și colaboratorii în World Allergy Organization Journal (2023), diagnosticul alergiei la proteinele laptelui de vacă (APLV) de severitate ușoară până la moderată la sugari presupune o abordare structurată în trei etape⁽¹⁾.

Tabelul 4 Recomandări privind managementul alergiei alimentare mediate IgE (tradus după Santos AF et al.)⁽⁷⁾

Subiect	Recomandări	Certitudinea dovezilor	Forța recomandării
Management dietetic	1. La pacienții cu alergie alimentară mediată IgE confirmată se recomandă evitarea alimentului (sau formei alimentului) la care pacientul este alergic.	Scăzută	Puternică
	2. La pacienții cu alergie alimentară mediată IgE confirmată se recomandă continuarea consumului alimentelor tolerate.	Moderată*	Puternică
	3. La pacienții cu alergie alimentară mediată IgE confirmată se sugerează oferirea unui consiliu dietetic individualizat în funcție de vârstă, cu sprijinul unui dietetician specializat în cazurile complexe, dacă este posibil.	Foarte scăzută	Condițională
Suport psihologic	4. La anumiți pacienți cu alergie alimentară mediată IgE și îngrijitorii acestora se sugerează suport psihologic oferit de un profesionist din domeniul sănătății instruit în acest sens.	Scăzută	Condițională
Plan de tratament	5. La pacienții cu alergie alimentară mediată IgE se recomandă realizarea unui plan de management individualizat.	Scăzută*	Puternică
	6. La pacienții cu alergie alimentară mediată IgE cu risc de anafilaxie se recomandă prescrierea de autoinjectoare cu adrenalină pentru a fi purtate permanent.	Scăzută*	Puternică
	7. La pacienții cu alergie alimentară mediată IgE cu risc de anafilaxie se recomandă un antrenament structurat și cuprinzător pentru recunoașterea anafilaxiei și utilizarea autoinjectoarelor de adrenalină, în completarea instrucțiunilor de bază privind utilizarea acestora.	Scăzută*	Puternică
Imunoterapie specifică alergenului (AIT)	8. La pacienții eligibili cu alergie alimentară mediată IgE pentru imunoterapia specifică alergenului se recomandă administrarea acesteia sub îndrumarea unei echipe clinice cu experiență în imunoterapia alimentară și în gestionarea efectelor adverse și a anafilaxiei.	Scăzută*	Puternică
AIT pentru alergia la arahide	9. La copiii și adolescenții cu alergie alimentară mediată IgE la arahide se recomandă imunoterapia orală pentru arahide, în scopul obținerii desensibilizării.	Ridică	Puternică
	10. La copiii și adolescenții cu alergie alimentară mediată IgE la arahide se sugerează imunoterapia epicutanată la arahide, dacă este disponibilă, pentru obținerea desensibilizării.	Ridică	Condițională
	11. La copiii și adolescenții cu alergie alimentară mediată IgE la arahide se sugerează imunoterapia sublinguală la arahide pentru obținerea desensibilizării.	Moderată	Condițională
AIT pentru alergia la ou	12. La copiii (în general peste 4 ani) și adolescenții cu alergie alimentară mediată IgE la ou se sugerează imunoterapia orală la ou pentru obținerea desensibilizării.	Scăzută	Condițională
AIT pentru alergia la laptele de vacă	13. La copiii (în general peste 4 ani) și adolescenții cu alergie alimentară mediată IgE la laptele de vacă se sugerează imunoterapia orală la lapte pentru obținerea desensibilizării.	Scăzută	Condițională
Biologice	14. La pacienții cu alergie alimentară mediată IgE se sugerează utilizarea omalizumab, pentru obținerea desensibilizării.	Moderată	Condițională

AIT = imunoterapie specifică alergenului; * Certitudinea scăzută a dovezilor justifică forța recomandării date.

Primul pas constă în inițierea unei diete de eliminare diagnostică pe termen scurt, care implică excluderea completă a proteinelor laptelui de vacă din alimentația copilului. Această etapă este urmată de monitorizarea simptomelor utilizând scoruri clinice standardizate, cum ar fi CoMiSS (Cow's Milk-related Symptom Score), pe o perioadă de 2 până la 4 săptămâni⁽⁶⁾.

Dacă după această perioadă simptomele se remit complet sau se ameliorează semnificativ, se recomandă reintroducerea laptelui de vacă în dietă, pentru confirmarea diagnosticului. În schimb, dacă nu se observă o ameliorare clinică, se procedează la reintroducerea laptelui și investigarea altor posibile cauze ale simptomelor, deoarece diagnosticul de APLV este puțin probabil⁽⁶⁾.

În etapa de reintroducere:

- Dacă simptomele reapar, diagnosticul de APLV este confirmat, iar pacientul continuă dieta de eliminare pe termen lung, cu reevaluare periodică la fiecare 6–12 luni pentru a verifica dobândirea toleranței naturale.
- Dacă simptomele nu reapar, diagnosticul de APLV este exclus și alimentația normală, incluzând proteinele laptelui de vacă, poate fi reluată fără restricții suplimentare.

Această abordare graduală, diagnostică și terapeutică, are rolul de a preveni supradiagnosticarea APLV și de a evita eliminarea inutilă a laptelui de vacă din alimentație, când nu este necesar⁽⁶⁾.

Management și Tratament al Alergiei la Proteinele Laptelui de Vacă (APLV)

Recomandări de management în alergia IgE-mediată la proteinele laptelui de vacă

La pacienții cu alergie IgE-mediată confirmată, este de primă intenție recomandată evitarea alimentului incriminat, însă, dacă ne referim strict la alergia IgE-mediată la proteinele laptelui de vacă, excluderea totală nu este recomandată dacă pacientul tolerează proteinele înalt preparate termic.

Recomandări actualizate de îngrijire a pacientului cu alergii alimentare IgE-mediate au fost recent publicate și sunt rezumate în tabelul IV⁽⁷⁾.

Prescrierea autoinjectorului de adrenalină (AAI) în alergia alimentară mediată IgE se recomandă în prezența unor **indicații absolute**, cum ar fi: episoade anterioare de anafilaxie indusă de alimente, astm bronșic instabil sau persistent moderat până la sever și mastocitoză sistemică subiacentă⁽⁶⁾.

Tabelul 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nr.	Întrebare clinică	Recomandare	Tip de recomandare	Certitudinea dovezilor
1A	OIT cu lapte de vacă nepreparat termic vs evitarea completă a laptelui	Se sugerează utilizarea OIT la pacienții care valorizează posibilitatea de a consuma lapte (chiar și în cantități mici) și acordă o importanță mai mică riscului de reacții alergice.	Condiționată	Moderată
1B	OIT cu lapte de vacă neîncălzit vs evitarea completă a laptelui	Se sugerează să nu se utilizeze OIT la pacienții care pun accent mai mare pe evitarea reacțiilor alergice și mai puțin pe consumul de lapte.	Condiționată	Moderată
2	Utilizarea tratamentului cu omalizumab în timpul OIT cu lapte de vacă nepreparat termic	Se sugerează utilizarea tratamentului cu omalizumab în fazele inițiale ale OIT pentru reducerea riscului de reacții adverse severe.	Condiționată	Foarte scăzută
3	OIT cu lapte de vacă copt la pacienți care nu tolerează laptele copt	Se sugerează să nu se utilizeze OIT cu lapte copt la pacienții care reacționează la doze mici de lapte copt.	Condiționată	Foarte scăzută
4	Imunoterapia epicutanată (EPIT) cu lapte de vacă	Se recomandă ferm ca EPIT să nu fie utilizată în afara contextului de cercetare.	Puternică	Foarte scăzută

De asemenea, există **indicații relative** pentru prescriere, care includ: reacții alergice la alimente cunoscute ca fiind asociate cu anafilaxia, reacții la urme de alimente, statutul de adolescent sau adult tânăr, acces limitat la îngrijire medicală (inclusiv călătorii îndelungate în zone izolate) și pacienți aflați în curs de imunoterapie specifică alergenului⁽⁶⁾.

Imunoterapia orală (OIT) este limitată la pacienții cu alergie la proteinele laptelui de vacă mediată IgE și reprezintă metoda care poate ajuta la prevenirea anafilaxiei și a reacțiilor severe secundare expunerilor accidentale⁽⁶⁾. OIT constă în ingestia zilnică de doze progresiv crescânde de alergen în faza de creștere a dozei, urmată de administrarea unei doze constante în faza de menținere, conform unor protocoale specifice. Aplicarea OIT la copiii cu CMA severă și persistentă merită a fi luată în considerare, însă în prezent această abordare trebuie rezervată pacienților selecționați și limitată la centre specializate⁽⁶⁾.

În ghidul DRACMA, alocat evaluării imunoterapiei ca soluție terapeutică pentru alergia la proteinele laptelui de vacă, regăsim principalele întrebări și răspunsuri sintetizate în tabelul 5⁽⁸⁾.

Recomandările ghidului DRACMA sprijină deciziile informate ale clinicienilor, pacienților cu APLV IgE-mediate și ale aparținătorilor lor. Punctul forte al ghidului constă în contribuția unei echipe internaționale formate din medici, cercetători și pacienți, care au realizat analize sistematice și au urmat metodologia GRADE pentru elaborarea recomandărilor. Totuși dovezile disponibile au limitări importante. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a evalua eficiența costurilor și aplicabilitatea OIT în practică, iar rezultatele viitoare ar putea modifica sau rafina recomandările actuale⁽⁸⁾.

Recomandări de management în alergia non-IgE-mediată la proteinele laptelui de vacă

Laptele matern reprezintă sursa nutrițională ideală pentru sugarii diagnosticați cu afecțiuni alergice non-IgE-mediate, iar profesioniștii din domeniul sănătății sunt încurajați să promoveze alăptarea exclusivă până la vârsta de aproximativ șase luni, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății⁽⁹⁾. Incidența alergiei alimentare la sugarii alimentați exclusiv cu lapte

matern rămâne un subiect de dezbatere, din cauza absenței studiilor randomizate controlate, a variabilității nivelului de alergen alimentar detectat în lapte și a incertitudinilor privind relevanța clinică. Excluderea nejustificată a unor alimente din dieta mamei în timpul alăptării trebuie evitată, pentru a proteja atât nutriția mamei și copilului, cât și calitatea vieții acestora. În cazul în care se impune o dietă de eliminare la mamă, din suspiciunea unei alergii alimentare non-IgE-mediate, reintroducerea alimentului eliminat trebuie realizată la 2–4 săptămâni, pentru confirmarea diagnosticului. Consilierea nutrițională ar trebui realizată de un dietetician sau nutriționist, cu monitorizarea atentă a aportului de vitamină D, calciu și iod, precum și a stării generale de sănătate a mamei^(9,10).

Proctocolita alergică – PAIPA

Managementul presupune eliminarea alimentului implicat (de cele mai multe ori laptele de vacă sau soia) din dieta sugarului sau din alimentația maternă, dacă acesta este alăptat. Este esențială menținerea alăptării când este posibil, iar în caz de dietă de eliminare maternă se recomandă suplimentarea cu calciu. Reintroducerea alimentului eliminat este indicată după o perioadă de evitare, de regulă în jurul vârstei de un an, pentru evaluarea dezvoltării toleranței⁽⁵⁾.

Enteropatia indusă de proteine alimentare – EIPA

Se recomandă eliminarea alimentului suspectat, în special a laptelui de vacă sau glutenului, din dieta copilului. În cazul alergiei la proteinele din laptele de vacă se utilizează formule extensiv hidrolizate, iar în cazurile severe, formule pe bază de aminoacizi. După o perioadă de evitare de 6–12 luni, alimentul eliminat trebuie reintrodus pentru a testa inducerea toleranței⁽⁵⁾.

Sindrom de enterocolită indus de proteine alimentare – SEIPA

Managementul constă în evitarea strictă a alimentului declanșator. Familiile trebuie instruite cu privire la elaborarea unui plan de acțiune în caz de reacție acută, care să includă administrarea de fluide intravenoase și ondansetron în reacțiile severe. Reintroducerea alimentului suspectat se efectu-

ează într-un cadru controlat, sub supraveghere medicală, de obicei după o perioadă de 12–18 luni de la ultimul episod⁽⁵⁾.

Esofagita eozinofilică – EoE

Tratamentul inițial recomandat este reprezentat de inhibitori ai pompei protoni (IPP). În caz de lipsă de răspuns, se indică utilizarea corticosteroizilor topici înghițiți (budesonid sau fluticazonă). De asemenea, se poate adopta o dietă empirică de eliminare, începând cu excluderea laptei de vacă, urmată progresiv de alte grupe alimentare. În formele severe sau refractare se recomandă inițierea terapiei biologice cu dupilumab⁽⁵⁾.

Reflux gastroesofagian provocat de proteine alimentare

Se recomandă implementarea unei diete de eliminare a laptei de vacă pentru o perioadă limitată (2–6 săptămâni), ca test terapeutic. După ameliorarea simptomelor se practică reintroducerea alimentului, pentru a evalua necesitatea menținerii restricției⁽⁵⁾.

Constipația indusă de proteine alimentare

În caz de constipație severă neresponsivă la măsurile uzuale se recomandă optimizarea aportului de fibre și lichide. Dacă simptomatologia persistă, poate fi inițiată o dietă de eliminare a laptei de vacă. Reintroducerea alimentului eliminat este importantă, pentru a confirma necesitatea continuării dietei de excludere⁽⁵⁾.

Concluzii

Alergia la proteinele laptei de vacă (APLV) rămâne cea mai frecventă alergie alimentară în rândul sugarilor și copiilor mici, necesitând o abordare diagnostică și terapeutică atentă și individualizată. Stabilirea diagnosticului corect este esențială pentru a preveni atât expunerea inutilă la restricții alimentare, cât și riscul de reacții alergice severe. În formele IgE-mediate, managementul standard presupune evitarea strictă a laptei și a produselor derivate, educarea pacientului și a familiei privind administrarea adrenalinei autoinjectabile și evaluarea oportunității imunoterapiei orale. Imunoterapia orală poate reprezenta o opțiune terapeutică pentru pacienți atent selectați, având potențialul de a crește pragul de reactivitate și de a îmbunătăți calitatea vieții, însă rămâne o procedură asociată cu riscuri, recomandată a fi realizată în centre specializate. Utilizarea omalizumab ca adjuvant în timpul imunoterapiei orale poate spori siguranța. În formele non-IgE-mediate, managementul de bază constă în dieta de eliminare a alimentului incriminat, cu reintroducerea alimentelor într-un mod controlat, pentru confirmarea diagnosticului și evaluarea dezvoltării toleranței. În cazurile complicate, precum esofagita eozinofilică, este indicat tratamentul farmacologic combinat cu diete de eliminare ghidate. În concluzie, managementul APLV trebuie să fie personalizat, ținând cont de profilul de risc al pacientului, de severitatea simptomelor și de preferințele familiale, în scopul optimizării rezultatelor clinice și al îmbunătățirii calității vieții. ■

Bibliografie

- Jensen SA, Fiocchi A, Baars T, Jordakieva G, Nowak-Węgrzyn A, Pali-Schöll I, Passanisi S, Pranger CL, Roth-Walter F, Takkinen K, Assa'ad AH, Venter C, Jensen-Jarolim E; WAO DRACMA guideline group. Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk Allergy (DRACMA) Guidelines update – III – Cow's milk allergens and mechanisms triggering immune activation. *World Allergy Organ J.* 2022 Sep 15;15(9):100668. doi: 10.1016/j.waojou.2022.
- Vandenplas Y, Broekaert I, Domellöf M, Indrio F, Lapillonne A, Pienar C, Ribes-Koninckx C, Shamir R, Szajewska H, Thapar N, Thomassen RA, Verduci E, West C. An ESPGHAN Position Paper on the Diagnosis, Management, and Prevention of Cow's Milk Allergy. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2024 Feb;78(2):386–413. doi: 10.1097/MPG.0000000000003897.
- Fiocchi A, Bognanni A, Brozek J, Ebisawa M, Schünemann H; WAO DRACMA guideline group. World Allergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk Allergy (DRACMA) Guidelines update – I – Plan and definitions. *World Allergy Organ J.* 2022 Feb 1;15(1):100609. doi: 10.1016/j.waojou.2021.
- Santos AF, Riggioni C, Agache I, Akdis CA, Akdis M, Alvarez-Perea A, Alvaro-Lozano M, Ballmer-Weber B, Barni S, Beyer K, Bindslev-Jensen C, Brough HA, Buyukiryaki B, Chu D, Del Giacco S, Dunn-Galvin A, Eberlein B, Ebisawa M, Eigenmann P, Eiwegger T, Feeney M, Fernandez-Rivas M, Fiocchi A, Fisher HR, Fleischer DM, Giovannini M, Gray C, Hoffmann-Sommergruber K, Halcken S, O'B Hourihane J, Jones CJ, Jutel M, Knol EF, Konstantinou GN, Lack G, Lau S, Mejias AM, Marchisotto MJ, Meyer R, Mortz CG, Moya B, Muraro A, Nilsson C, de Oliveira LCL, O'Mahony L, Papadopoulos NG, Perrett KP, Peters R, Podesta M, Poulsen LK, Roberts G, Sampson H, Schwarze J, Smith P, Tham E, Untersmayr E, Van Ree R, Venter C, Vickery B, Vlieg-Boerstra B, Werfel T, Worm M, Du Toit G, Skypala I. EAACI guidelines on the management of IgE-mediated food allergy. *Allergy.* 2025 Jan;80(1):14–36. doi: 10.1111/all.16345. Epub 2024 Oct 30.
- Meyer R, Cianferoni A, Vazquez-Ortiz M. An update on the diagnosis and management of non-IgE-mediated food allergies in children. *Pediatr Allergy Immunol.* 2025 Mar;36(3):e70060. doi: 10.1111/pai.70060.
- Meyer R, Venter C, Bognanni A, Szajewska H, Shamir R, Nowak-Węgrzyn A, Fiocchi A, Vandenplas Y; WAO DRACMA Guideline Group. World Allergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk Allergy (DRACMA) Guideline update – VII – Milk elimination and reintroduction in the diagnostic process of cow's milk allergy. *World Allergy Organ J.* 2023 Jul 24;16(7):100785. doi: 10.1016/j.waojou.2023.100785.
- Santos AF, Riggioni C, Agache I, Akdis CA, Akdis M, Alvarez-Perea A, Alvaro-Lozano M, Ballmer-Weber B, Barni S, Beyer K, Bindslev-Jensen C, Brough HA, Buyukiryaki B, Chu D, Del Giacco S, Dunn-Galvin A, Eberlein B, Ebisawa M, Eigenmann P, Eiwegger T, Feeney M, Fernandez-Rivas M, Fiocchi A, Fisher HR, Fleischer DM, Giovannini M, Gray C, Hoffmann-Sommergruber K, Halcken S, O'B Hourihane J, Jones CJ, Jutel M, Knol EF, Konstantinou GN, Lack G, Lau S, Mejias AM, Marchisotto MJ, Meyer R, Mortz CG, Moya B, Muraro A, Nilsson C, de Oliveira LCL, O'Mahony L, Papadopoulos NG, Perrett KP, Peters R, Podesta M, Poulsen LK, Roberts G, Sampson H, Schwarze J, Smith P, Tham E, Untersmayr E, Van Ree R, Venter C, Vickery B, Vlieg-Boerstra B, Werfel T, Worm M, Du Toit G, Skypala I. EAACI guidelines on the management of IgE-mediated food allergy. *Allergy.* 2025 Jan;80(1):14–36. doi: 10.1111/all.16345.
- Brozek JL, Firmino RT, Bognanni A, Arasi S, Ansoetegui I, Assa'ad AH, Bahna SL, Canani RB, Bozzola M, Chu DK, Dahdah L, Dupont C, Dziechciarz P, Ebisawa M, Galli E, Horvath A, Kamenwa R, Lack G, Li H, Martelli A, Nowak-Węgrzyn A, Papadopoulos NG, Pawankar R, Roldan Y, Said M, Sánchez-Borges M, Shamir R, Spergel JM, Szajewska H, Terracciano L, Vandenplas Y, Venter C, Waffenschmidt S, Wasserman S, Warner A, Wong GWK, Fiocchi A, Schünemann HJ. World Allergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk Allergy (DRACMA) Guideline update – XIV – Recommendations on CMA immunotherapy. *World Allergy Organ J.* 2022 Apr 23;15(4):100646. doi: 10.1016/j.waojou.2022.100646.
- Meyer R, Chebar Lozinsky A, Fleischer DM, et al. Diagnosis and management of non-IgE gastrointestinal allergies in breastfed infants—an EAACI position paper. *Allergy.* 2019;75(1):14–32. doi: 10.1111/all.13947.
- Boyle RJ, Shamji MH. Milk allergy over-diagnosis. *Clin Exp Allergy.* 2022;52(1):4–6.

CONFLICT DE INTERESE: niciunul declarat.
SUPORT FINANCIAR: niciunul declarat.



Acest articol este accesibil online, fără taxă, fiind publicat sub licența CC-BY.